

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



ESCUELA DE POSGRADO

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA
EN GERENCIA Y GESTIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD**

**ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y SATISFACCIÓN
DEL PACIENTE. SERVICIO RADIOLOGÍA HOSPITAL
REGIONAL AMAZONAS, 2024**

Autora:

Bach. Greisy Gledys Zapata Baca

Asesora:

Ms. Sonia Celedonia Huyhua Gutierrez

Registro: (...)

CHACHAPOYAS – PERÚ

2025

DEDICATORIA

Dedico mi tesis principalmente a Dios, por brindarme la energía requerida para alcanzar este objetivo. A mi familia, en particular a mis padres, les agradezco sinceramente su amor sin reservas y su respaldo ininterrumpido, su confianza en mí ha sido el impulso que me ha facilitado finalizar este recorrido, a mi hermana, cuñado y sobrino, por sus palabras de apoyo, por su presencia y afecto, gracias por ser mi sostén en las situaciones adversas, sin ellos, esta conquista no habría sido factible.

AGRADECIMIENTO

Me gustaría iniciar expresando mi más profundo agradecimiento a la Mg. Sonia Huyhua Gutierrez, cuya experiencia, paciencia y respaldo continuo, fueron esenciales para llevar a cabo este estudio.

A la Escuela de Posgrado, por brindarme la oportunidad de formar parte de este prestigioso programa, alcanzando valiosos conocimientos y habilidades que han sido esenciales para el desarrollo de esta tesis.

Al jefe del departamento de diagnóstico por imágenes, por concederme el acceso a los recursos y equipos del servicio, los cuales fueron cruciales para el desarrollo de mi investigación.

Finalmente, a los pacientes que se atendieron en el servicio de radiología, su disposición, confianza y colaboración fueron fundamentales para la obtención de los datos necesarios para mi investigación, agradezco profundamente su tiempo y la apertura con la que compartieron sus experiencias, las cuales han sido clave para el avance de este trabajo.

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS**

Ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana

Rector

Dr. Oscar Andrés Gamarra Torres

Vicerrector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza

Vicerrectora de Investigación

Dr. Efraín Manuelito Castro Alayo

Director de la Escuela de Posgrado

JURADO EVALUADOR DE LA TESIS



Dr. Wilfredo Amaro Cáceres

Presidente



Mg. Hitler Adolfo Vela Zuta

Secretario



Mg. Miguel Angel Perez Altamirano

Vocal

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS



UNTRM

REGlamento del Proceso de Graduación
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO
DE MAESTRO / DOCTOR
R.C.U N° 328-2023

ANEXO 3

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador del Proyecto de Tesis ()/Tesis (X)/Tesis en formato de artículo científico () titulado:

"Acceso a servicios de salud y satisfacción del paciente.
Servicio Radiología Hospital Regional Amazonas, 2024"

presentado por el Aspirante Greisy Gledys Zapata Bara para obtener el Grado Académico de Maestro (X)/Doctor () en Gerencia y Gestión en los servicios de salud de la Escuela de Posgrado de la UNTRM, hacemos constar que después de revisar la originalidad del Proyecto de Tesis ()/Tesis (X)/Tesis en formato de artículo científico () con el software de prevención de plagio **Turnitin**, verificamos:

- a) De acuerdo con el informe de originalidad, el Proyecto de Tesis ()/Tesis (X)/Tesis en formato de artículo científico () tiene 24 % de similitud, que es menor al 25% permitido en la UNTRM.
- b) La persona responsable de someter el trabajo al software de prevención de plagio **Turnitin** fue: Dr. Wilfredo Amaro Cáceres y pertenece al área () / oficina () / dependencia (X) de FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD



SE ADJUNTA:

- Resultado del informe del software **Turnitin**.

Chachapoyas, 03 de MARZO del 2025

PRESIDENTE

Nombres y apellidos:

WILFREDO
AMARO CÁCERES

DNI: 41983973

SECRETARIO

Nombres y apellidos:

JHON ADOLO
VELA ZUTA

DNI: 33808582

VOCAL

Nombres y apellidos:

MIGUEL ANGEL
PÉREZ ALTAMIRANO

DNI: 10809176

OBSERVACIONES:

REPORTE DE TURNITIN

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y SATISFACCIÓN DEL PACIENTE. SERVICIO RADIOLOGÍA HOSPITAL REGIONAL AMAZONAS, 2024

INFORME DE ORIGINALIDAD

24%

INDICE DE SIMILITUD

23%

FUENTES DE INTERNET

7%

PUBLICACIONES

9%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

4%

2

repositorio.untrm.edu.pe

Fuente de Internet

3%

3

hdl.handle.net

Fuente de Internet

2%

4

repositorio.unjfsc.edu.pe

Fuente de Internet

1%

5

Submitted to Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Trabajo del estudiante

1%

6

www.comexperu.org.pe

Fuente de Internet

1%

7

repositorio.uma.edu.pe

Fuente de Internet

1%

8

www.ipsos.com

Fuente de Internet

1%



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO DEL PROCESO DE GRADUACIÓN
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO
DE MAESTRO / DOCTOR
R.C.U N° 328-2023

ANEXO 5

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En el Auditorio de la Escuela de Posgrado de la UNTRM - Chachapoyas, el día 05 de marzo del año 2025, siendo las 12:30pm horas, el Aspirante Bach. Greisy Gledys Zapata Baca, cuyo asesor es Mg. Sonia Celedonia Huyhua Gutiérrez, defiende en sesión pública presencial la Tesis titulada: "Acceso a servicios de Salud y Satisfacción del paciente. Servicio Radiología Hospital Regional Amazonas, 2024"

para obtener el Grado Académico de Maestro (X) / Doctor () en Gerencia y Gestión en los servicios de salud, a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, ante el Jurado Evaluador, conformado por:

Presidente: Dr. Wilfredo Amaro Cáceres

Secretario: Mg. Hitler Adolfo Vela Zuta

Vocal: Mg. Miguel Angel Pérez Altamirano



Luego de la sustentación y absueltas las preguntas del Jurado Evaluador se procedió a la calificación individual y secreta, teniendo el resultado de:

Aprobada (X)/Desaprobada () por Unanimidad (X)/Mayoría ().

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación, se levanta la sesión.

Siendo las 1:30pm horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis.

PRESIDENTE

Nombres y apellidos: Wilfredo Amaro Cáceres

DNI: 41983973

SECRETARIO

Nombres y apellidos: Hitler Adolfo Vela Zuta

DNI: 33808582

VOCAL

Nombres y apellidos: Miguel Angel Pérez Altamirano
DNI: 10809178

ASESOR

Nombres y apellidos: Sonia Celedonia Huyhua Gutiérrez
DNI: 40623694

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	iv
JURADO EVALUADOR DE LA TESIS	v
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS.....	vi
REPORTE DE TURNITIN	vii
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS.....	viii
ÍNDICE GENERAL	ix
ÍNDICE DE TABLAS	x
ÍNDICE DE ANEXOS	xi
RESUMEN	xii
ABSTRACT.....	xiii
I. INTRODUCCIÓN.....	13
II. MATERIAL Y MÉTODOS	17
III. RESULTADOS	23
IV. DISCUSIÓN	32
V. CONCLUSIONES.....	36
VI. RECOMENDACIONES.....	37
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38
ANEXOS	41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. <i>Relación entre el acceso a los servicios de salud y satisfacción del paciente...</i>	23
Tabla 2. <i>Nivel de acceso a los servicios de salud que tiene el paciente del servicio de radiología según dimensiones: geográfica, sociocultural, económica, y administrativa organizacional.....</i>	24
Tabla 3. <i>Nivel de satisfacción del paciente del servicio de radiología según dimensiones: fiabilidad, respuesta, garantía y empatía.....</i>	24
Tabla 4. <i>Relación entre las dimensiones de acceso a los servicios y satisfacción.....</i>	25
Tabla 5. <i>Variables sociodemográficas según el acceso a servicios de salud.....</i>	28
Tabla 6. <i>Variables sociodemográficas según la satisfacción del paciente.....</i>	30

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 2. <i>Cuestionario de acceso a los servicios de salud</i>	44
Anexo 3. <i>Encuesta de satisfaccion del paciente</i>	46
Anexo 4. <i>Consentimiento informado</i>	47
Anexo 5. <i>Validacion del instrumento acceso a servicios de salud</i>	48
Anexo 6. <i>Confiabilidad de instrumento acceso a servicios de salud</i>	49
Anexo 7. <i>Validacion de instrumento satisfaccion del paciente</i>	50
Anexo 8. <i>Confiabilidad de instrumento de satisfaccion de paciente</i>	51
Anexo 9. <i>Carta de solicitud de aprobacion de protecto de tesis</i>	52
Anexo 10. <i>Constancia de aprobacion por comité de ética</i>	53
Anexo 11. <i>Carta de solicitud de ejecución del proyecto</i>	54
Anexo 12. <i>Certificación de ejecución de tesis</i>	55

RESUMEN

Trabajo de investigación aplicada de enfoque cuantitativo, estudio transversal de tipo correlacional que tuvo como objetivo determinar la relación entre el acceso a los servicios de salud y la satisfacción del paciente en el servicio de radiología del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas. Se trabajó con una muestra probabilística de 340 pacientes, se utilizó el cuestionario para poder medir las variables. Se encontró que existe correlación entre el acceso a los servicios de salud y la satisfacción del paciente (Chi-cuadrado de Pearson 32.169^a, valor de $p = 0,000$), asimismo se observa que las dimensiones geográfica, administrativa, sociocultural y económica, predomina el regular acceso a los servicios (70%, 66.5%, 72.1% y 69.4%, respectivamente), así como las dimensiones de fiabilidad, respuesta, garantía y empatía, predomina una satisfacción media (63.5%, 60%, 51.5% y 52.1%, respectivamente), de los pacientes atendidos en el servicio de rayos x. Asimismo se encontró una correlación significativa entre las dimensiones, fiabilidad y geográfica (Chi-cuadrado de Pearson 11,164^a, valor de $p=0,025$), respuesta y geográfica (Chi-cuadrado de Pearson 21,468^a, valor de $p=0,000$), garantía y geográfica (Chi-cuadrado de Pearson 57,398^a, valor de $p=0,000$), empatía y geográfica (Chi-cuadrado de Pearson 26,001^a, valor de $p=0,000$), fiabilidad y administración (Chi-cuadrado de Pearson 12.017^a, valor de $p=0,017$) fiabilidad y geográfica (Chi-cuadrado de Pearson 32.169, valor de $p=0,025$). Estos hallazgos, enfatizan el valor de optimizar las condiciones de acceso a los servicios de salud como una táctica esencial para aumentar la satisfacción del paciente.

Palabras claves: acceso, servicios de salud, satisfacción, paciente, radiología.

ABSTRACT

Applied research work with a quantitative approach, a cross-sectional correlational study aimed at determining the relationship between access to health services and patient satisfaction in the radiology service of the Virgen de Fátima Regional Hospital in Chachapoyas. A probabilistic sample of 340 patients was used, and a questionnaire was employed to measure the variables. The study found a correlation between access to health services and patient satisfaction (Pearson Chi-square 32.169a, p-value = 0.000). Furthermore, it was observed that in the geographical, administrative, sociocultural, and economic dimensions, regular access to services predominated (70%, 66.5%, 72.1%, and 69.4%, respectively), as well as the dimensions of reliability, responsiveness, assurance, and empathy, where medium satisfaction predominated among patients in the X-ray service (63.5%, 60%, 51.5%, and 52.1%, respectively). A significant correlation was also found between the dimensions: reliability and geography (Pearson Chi-square 11.164a, p-value = 0.025), responsiveness and geography (Pearson Chi-square 21.468a, p-value = 0.000), assurance and geography (Pearson Chi-square 57.398a, p-value = 0.000), empathy and geography (Pearson Chi-square 26.001a, p-value = 0.000), reliability and administration (Pearson Chi-square 12.017a, p-value = 0.017), and reliability and geography (Pearson Chi-square 32.169, p-value = 0.025). These findings emphasize the importance of optimizing access conditions to health services as a key strategy to increase patient satisfaction.

Keywords: *access, health services, satisfaction, patient, hospital, radiology.*

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el porcentaje de la población que carece de los servicios de salud básicos disminuyó alrededor del 15% entre 2000 y 2021, aunque desde 2015 se registraron escasos progresos. Esto significa que, para 2021, aproximadamente 4500 millones de individuos no contaban con la totalidad de los servicios de salud esenciales. Aproximadamente 2000 millones de individuos enfrentan problemas económicos a causa del desembolso que realizan en servicios de salud, de los cuales 1000 millones enfrentan niveles de gastos directos catastróficos por este motivo y 344 millones se encuentran en situación de pobreza extrema (Organización Mundial de la Salud, 2023).

Es así que no se está progresando adecuadamente para lograr la cobertura de salud universal para 2030, que es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2015, comenzó a notarse un descenso en el incremento de la cobertura de los servicios sanitarios, y el porcentaje de la población que sufre niveles de gasto directo catastróficos en atención médica no ha cesado de aumentar desde el año 2000, este modelo global se aplica en todas las áreas geográficas y en la mayoría de las naciones (OMS, 2023).

En Australia (81%), los Países Bajos (76%) y Gran Bretaña (74%), los servicios sanitarios son los más apreciados por la población. Los tres países en los que las personas suelen calificar su atención sanitaria como "deficiente" son Polonia (53%), Hungría (42%) y Perú (40%). En términos generales, las personas también manifiestan un incremento en su sentido de confianza en que serán atendidas con la mejor calidad en los servicios de salud de su nación (IPSOS, 2020).

En relación con las percepciones de desigualdades en salud, el 59% a nivel global sostiene que numerosas personas no tienen la capacidad de costear una atención médica de calidad en su nación. Esto supera el 8 de cada 10 acuerdos en siete naciones (Sudáfrica, Perú, Chile, Hungría, Brasil, Polonia y Argentina) Los individuos también están divididos acerca de si los servicios sanitarios ofrecen el mismo nivel de atención para todos: el 37% coincide, mientras que el 38% discrepa, con ciertas discrepancias geográficas (IPSOS, 2020).

La satisfacción de los pacientes con los servicios de salud suele ser alta a nivel mundial, aunque varía dependiendo del país, la región y el tipo de atención, en muchos países, el nivel de satisfacción promedio se encuentra entre el 70% y el 80%, aunque en países más desarrollados puede ser superior debido a mejores condiciones en la atención médica, es así que estas cifras se ven con frecuencia influenciadas por varios factores, entre ellos, la calidad de la atención médica, la disponibilidad de profesionales de la salud, el tiempo de espera, la empatía del personal médico y la información proporcionada, cuando alguno de estos aspectos falla, la experiencia del paciente puede resultar insatisfactoria, además, el acceso a servicios de atención primaria juega un papel fundamental en la mejora de la salud de la población. (Organización Panamericana de la Salud, 2019).

A nivel de Perú, en términos de prestaciones, la condición de los centros de salud públicos es crítica: prácticamente el 100% de los centros de salud y hospitales poseen una capacidad de instalación deficiente, igualmente, están fragmentados y no se benefician de las sinergias de un trabajo estructurado en red, por ello, es habitual que pacientes de hospitales públicos acaben trasladándose a otro departamento, usualmente a la ciudad de Lima, para recibir atención médica; por otro lado, el financiamiento público es deficiente y se administra de manera ineficaz, aunque la cantidad de ciudadanos con seguro ha aumentado considerablemente en años recientes (supera el 98%), no se ha observado un aumento correspondiente en los fondos públicos destinados a cubrir las necesidades de estos nuevos asegurados, además, hay varios fondos públicos con normativas diferentes; el SIS, que cuenta con la mayor cantidad de afiliados (cerca de dos tercios del total), recibe fondos del tesoro público y depende del presupuesto asignado anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (Videnza Instituto, 2022).

Durante el cuarto trimestre de 2023, el 47,0% de los individuos con problemas de salud acudió a un centro sanitario, lo que implica un aumento de 3,5 puntos porcentuales en relación con el mismo periodo del año 2022, que registró un 43,5%. Respecto al cuarto trimestre de 2022, se registró el incremento más significativo en las instalaciones del Ministerio de Salud, con un incremento de 1,4 puntos porcentuales, ascendiendo del 12,9% al 14,3%. Además, de octubre a diciembre de 2023, el 88,6% de los individuos entrevistados correspondió al 88,6% de la población que fue entrevistada (Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG), 2024).

En el entorno de Amazonas, hasta el año 2020, se observó un aumento constante en la proporción de la población del departamento de Amazonas que estaba afiliada a un seguro de salud, pasando del 39,4% en 2007 al 88,4%, la mayoría de la población estaba inscrita en el Seguro Integral de Salud (SIS), representando el 74,9%, seguido por aquellos que estaban afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud), que constituían el 12,6%, en este sentido, por lo que, se anticipa que en el departamento de Amazonas esta tendencia continuará en aumento en los próximos diez años (CEPLAN, 2022).

En contexto, se planteó la siguiente interrogante ¿Qué relación existe entre el acceso a servicios de salud y la satisfacción del paciente en el servicio de radiología del Hospital Regional Virgen de Fátima de la región Amazonas, durante el primer trimestre 2024?, teniendo como hipótesis alternativa: existe relación estadísticamente significativa entre el acceso a los servicios de salud y la satisfacción del paciente en el área de Radiología del Hospital Regional Virgen de Fátima de Amazonas, durante un semestre del 2024 y como hipótesis nula: no existe relación estadísticamente significativa entre el acceso a los servicios de salud y la satisfacción del paciente en el área de Radiología del Hospital Regional Virgen de Fátima de Amazonas, durante un semestre de 2024. Con el objetivo general de determinar la relación entre el acceso a servicios de salud y satisfacción del paciente en el servicio de radiología del Hospital Regional Virgen de Fátima Amazonas (HRVFA), durante un periodo semestral del 2024.

Para el cumplimiento del objetivo general se plantearon objetivos específicos como es, identificar el acceso a los servicios de salud que tiene el paciente del servicio de radiología según dimensiones: geográfico, sociocultural, económico, y administrativo organizacional, medir la satisfacción del paciente del servicio de radiología según dimensiones: fiabilidad, respuesta, garantía y empatía, identificar la relación de la satisfacción del paciente según datos sociodemográficos: sexo, edad, nivel educativo, estado civil, tipo de trabajo y tipo de seguro, ingreso económico, identificar la relación del acceso a los servicios de salud, según datos sociodemográficos: sexo, edad, nivel educativo, estado civil, tipo de trabajo y tipo de seguro.

Esta investigación permite ofrecer una visión integral y detallada de los factores que inciden en la percepción del servicio de radiología, contribuyendo a identificar áreas de mejora y establecer bases sólidas para la optimización del Plan Operativo Institucional del Hospital, además de mejorar la calidad de atención por parte de los Tecnólogos

Médicos y Técnicos en Radiología, identificando barreras de acceso, optimizando recursos, evaluando políticas de salud, proporcionando al final información valiosa promover la equidad en el acceso a la atención y guiar la toma de decisiones estratégicas del hospital.

Es así que se presenta esta tesis, que abarca en el capítulo I: la introducción donde se enfoca la problemática de ambas variables en los diferentes contextos, planteamiento del problema, objetivos de investigación; seguidamente en el capítulo II se muestra la sección de materiales y métodos, donde se incluye el diseño del estudio, población muestra y procedimiento y análisis de datos; en el capítulo III se exponen los resultados de la investigación expresado a través de tablas simples y de doble entrada, con su análisis estadístico; en el capítulo IV se presenta la discusión de los resultados obtenidos y comparando con estudios previos, implicaciones, limitaciones y futuras recomendaciones; en el capítulo V se encuentran las conclusiones, donde se plasman el resumen de los hallazgos, respuestas a preguntas de investigación y aportaciones al conocimiento; finalmente en el capítulo VI se brindan las recomendaciones donde se plasman algunas futuras investigaciones en base a los resultados obtenidos.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

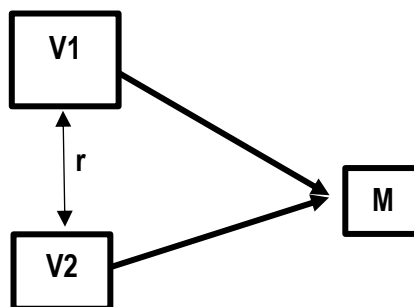
1.1. Enfoque, nivel y tipo de investigación

Este enfoque fue de tipo cuantitativo porque se recolectó datos para la comprobación de hipótesis con base a medidas numéricas y se utilizó análisis estadístico, lo que hace que este tipo de investigación sea fundamental porque se enfocó en obtener un nuevo conocimiento de manera sistemática a partir de una realidad concreta (Hernández & Mendoza, 2018)

El diseño de la investigación fue no experimental, transversal y correlacional. Esto se debe a que este tipo de investigación se centró en la observación de situaciones actuales en lugar de experimentar o manipular variables. Transversal porque los datos se recopilaron en un momento único y predeterminado exclusivamente en un semestre del año 2024. Y correlacional porque buscó describir una relación entre las variables (Hernández & Mendoza, 2018).

2.1.1. Diseño de investigación

El presente estudio fue de diseño no experimental. (Hernández & Mendoza, 2018)



Donde:

M: Pacientes que acudieron al servicio de radiología del Hospital Regional Virgen de Fátima

V₁: Acceso a servicios de salud

V₂: Satisfacción del paciente

r: Posible relación entre las variables de estudio

2.2. Población, muestra y muestreo

2.2.1. Población

La población de estudio estuvo conformada por 2987 pacientes desde el mes de abril hasta setiembre que se atendieron en el servicio de Rayos X, del departamento de diagnóstico por imágenes del Hospital Regional Virgen de Fátima de la región Amazonas (*Fuente: HIS Hospital Regional Virgen de Fátima, Área de estadística 2024*).

2.2.2. Muestra

La muestra estuvo conformada por 340 pacientes atendidos en el servicio de Rayos X del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas Amazonas. Obtenidos a través de la siguiente fórmula:

$$n = \frac{z^2 pqN}{E^2(N-1) + z^2 pq} \text{ (Sampieri, 2014)}$$

Donde:

Z: valor Z del nivel de significancia: 1.96

Nivel de significancia: 95%

p: probabilidad para el éxito: 0.5

q: probabilidad del fracaso: 0.5

E: Error permitido: 5%

N: población total: 2987

$$n = \frac{1.96^2(0.5)(0.5)2987}{0.0025(2987 - 1) + 1.96^2(0.5)(0.5)}$$

$$n = \frac{3.8416(0.5)(0.5)2987}{0.0025(2986) + 3.8416(0.5)(0.5)}$$

$$n = \frac{2868.7148}{7.169386}$$

$$n = 340$$

Criterios de inclusión y exclusión:

Inclusión:

- Pacientes que accedieron libremente a desarrollar las preguntas, a través de la firma en el consentimiento informado (Anexo 5).
- Pacientes que se realizaron examen de rayos x simple o con contraste.
- Pacientes mayores de edad.

Exclusión:

- Pacientes en hospitalización o emergencia.
- Pacientes que hayan presentado alguna discapacidad.
- Pacientes transeúntes.

2.2.3. Muestreo

El presente estudio utilizó el tipo de muestreo probabilístico simple y una muestra dirigida por beneficio ya que todos los participantes de la población fueron específicos y seleccionados con un propósito. (Hernández & Mendoza, 2018).

2.3. Técnica e instrumento de recolección de datos**Técnica**

En esta investigación, se utilizó la encuesta, que "es un conjunto de preguntas que persiguen evaluar algo y es calificado por el investigador". El método deductivo fue utilizado porque el estudio "se basa en hipótesis preestablecidas, que midieron variables y su aplicación se sujetó al diseño concebido con antelación; al desarrollarse, el investigador está centrado en la validez, el rigor y el control de la situación de investigación" (Hernández & Mendoza, 2018).

Instrumento

Los instrumentos que se utilizaron fueron los cuestionarios porque permitieron recopilar información de primera fuente de las variables a medir de manera rápida y eficaz (Hernández & Mendoza, 2018).

Para la variable 1: Acceso a los servicios de salud.

En esta investigación, se utilizó la encuesta, empleando un instrumento que consiste en un cuestionario validado por Pérez (2021), titulado "Acceso a los Servicios de Salud", este cuestionario consta de 16 ítems distribuidos en cuatro dimensiones, cada una de las cuales contiene cuatro ítems, se midió a través de una escala de tipo Likert, donde los ítems nunca que equivale a 1 punto, hasta siempre que tiene 5 puntos.

La categorización para la variable 1:

- Alto acceso : 59 – 80 puntos
- Regula acceso : 38 – 58 puntos
- Bajo acceso : 16 – 37 puntos

La categorización para las dimensiones:

- Dimensión geográfica:
 - Alto acceso : 16 – 20 puntos
 - Regular acceso : 10 – 15 puntos
 - Bajo acceso : 4 – 9 puntos
- Dimensión administrativo organizacional:
 - Alto acceso : 16 – 20 puntos
 - Regular acceso : 10 – 15 puntos
 - Bajo acceso : 4 – 9 puntos
- Dimensión sociocultural:
 - Alto acceso : 16 - 20 puntos
 - Regular acceso : 10 - 15 puntos
 - Bajo acceso : 4 - 9 puntos
- Dimensión económica:
 - Alto acceso : 16 - 20 puntos
 - Regular acceso : 10 - 15 puntos
 - Bajo acceso : 4 – 9 puntos

La validación del instrumento fue realizada por Pérez (2021), quien a través de juicio de expertos verificó la aplicabilidad del mismo (Anexo 7). La confiabilidad del instrumento fue obtenida a través de alfa de Cronbach, con 0.877, siendo fuerte confiabilidad (Anexo 8).

Para la variable 2: Satisfacción de paciente.

En el segundo cuestionario de esta investigación, se utilizó la técnica de entrevista personal, empleando un instrumento que consiste en un cuestionario validado por Gonzales (2022). Este instrumento consta de cuatro dimensiones y 15 preguntas para marcar a través de una escala de Likert, totalmente insatisfecho = 1, parcialmente insatisfecho = 2, parcialmente satisfecho = 3, medianamente satisfecho = 4, totalmente satisfecho = 5.

La categorización para la variable 2:

- Nivel bajo : 15 – 34 puntos
- Nivel medio : 35 – 54 puntos
- Nivel alto : 55 – 75 puntos

La categorización para las dimensiones:

- Dimensión fiabilidad:
 - Nivel bajo : 3 - 6 puntos
 - Nivel medio : 7 - 10 puntos
 - Nivel alto : 11 - 15 puntos
- Dimensión respuesta:
 - Nivel bajo : 4 - 9 puntos
 - Nivel medio : 10 - 14 puntos
 - Nivel alto : 15 - 20 puntos
- Dimensión garantía:
 - Nivel bajo : 4 - 9 puntos
 - Nivel medio : 10 - 14 puntos
 - Nivel alto : 15 - 20 puntos
- Dimensión empatía:
 - Nivel bajo : 4 - 9 puntos
 - Nivel medio : 10 - 14 puntos
 - Nivel alto : 15 - 20 puntos

La validación del instrumento fue realizado por Gonzales(2022), fue revisado por juicio de expertos (Anexo 5). La confiabilidad del instrumento fue obtenida a través de Alfa de Cronbach, con 0.998, siendo fuerte confiabilidad (Anexo 6). (Gonzales, 2022).

2.3.1. Procedimiento

- Se presentó el proyecto al comité de ética de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (Anexo 9).
- Aceptación del Comité de ética e investigación (Anexo 10).
- Se presentó una carta al director del Hospital Regional Virgen de Fátima de Amazonas, para solicitar el permiso en la ejecución de la investigación (Anexo 11).
- Aceptación por el área de investigación del HRVF (Anexo 12).

- Se coordinó con el jefe del área de diagnóstico por imágenes para el permiso correspondiente.
- Se coordinó con cada paciente después de ser atendidos en el área de Radiología para que puedan responder los instrumentos, previo consentimiento informado, recibiendo la información en la sala de espera y pasillos del departamento de diagnóstico por imágenes, tomándonos un tiempo entre 20 a 25 minutos.
- Después de administrar ambos instrumentos, se verificó el correcto llenado y se procedió a eliminar aquellos que se encontraban incompletos o inadecuadamente llenados.

2.4. Análisis de datos

Después de completar las encuestas, se procedió a codificar el instrumento asignando valores numéricos que se almacenaron en una hoja de Excel 2016 para crear la base de datos en el paquete estadístico SPSS v- 27. Para evaluar el objetivo general se realizó la correlación entre las variables acceso a servicios de salud y satisfacción del paciente, llevando a cabo una, una prueba no paramétrica de Chi Cuadrado, que requirió la preparación de tablas cruzadas.

Para el objetivo específico 1 sobre el acceso a los servicios de salud que tiene el paciente del servicio de radiología según dimensiones: geográfico, sociocultural, económico, y administrativo organizacional, se realizó con tablas simples y cruzadas, asimismo se llevara a cabo una prueba de Chi-cuadrado ya que se cumplen los requisitos para su aplicación, para el objetivo específico 2 sobre la satisfacción del paciente del servicio de radiología según dimensiones: fiabilidad, respuesta, garantía y empatía, se complementará con tablas de frecuencias y gráficos, asimismo, se llevará a cabo una prueba de Chi-cuadrado.

Para los objetivos específicos 3 y 4 se llevó a cabo un análisis de correspondencia múltiple para reducir las dimensiones, seguido de un análisis de conglomerados para agrupar las características similares de acceso a servicios de salud y satisfacción de paciente, se utilizará la distancia euclidiana como medida de similitud para el agrupamiento. Todos los análisis estadísticos se llevarán a cabo con un nivel de significancia de $p < 0.05$ utilizando el software estadístico SPSS.

III. RESULTADOS

Tabla 1.

Relación entre el acceso a los servicios de salud y satisfacción del paciente.

Acceso a los Servicios de salud	Satisfacción del paciente						Total	
	Bajo		Medio		Alto		fi	%
	fi	%	fi	%	fi	%		
Bajo	2	0.60%	4	1.20%	0	0%	6	1.80%
Regular	6	1.80%	204	60%	92	27.10%	302	88.80%
Alto	0	0%	16	4.70%	16	4.70%	32	9.40%
TOTAL	8	2.40%	224	65.90%	108	31.80%	340	100%

Nota. χ^2 de Pearson 32.169^a, gl= 4, valor de $p=0,000$

En la tabla 1, el 60 % de los pacientes experimentaron media satisfacción y regular acceso a los servicios de salud, el 27.10% manifestaron alta satisfacción con regular acceso a los servicios de salud, y solo el 1.80% demostraron baja satisfacción con regular acceso.

Además, se obtuvo el valor de Chi-cuadrado de Pearson con 32.169 y el valor de $p = 0,000$, lo que revela que hay una relación estadísticamente significativa entre el acceso a los servicios de salud y la satisfacción del paciente.

Tabla 2.

Nivel de acceso a los servicios de salud que tiene el paciente del servicio de radiología según dimensiones: geográfica, sociocultural, económica, y administrativa organizacional.

Dimensiones	Acceso a los servicios de salud								Total	
	Geográfica		Administración		Sociocultural		Económica		fi	%
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%		
Bajo	13	3.8%	61	17.9%	17	5%	85	25%	340	100%
Regular	238	70%	260	76.5%	245	72.1%	236	69.4%	340	100%
Alto	89	26.2%	19	5.6%	78	22.9%	19	5.6%	340	100%

Nota. Instrumento aplicado

En la tabla 2, se observa que, referente a las dimensiones de acceso a los servicios de salud: geográfica, administrativa, sociocultural y económica, predomina el regular acceso a los servicios (70%, 66.5%, 72.1% y 69.4%, respectivamente).

Tabla 3.

Nivel de satisfacción del paciente del servicio de radiología según dimensiones: fiabilidad, respuesta, garantía y empatía.

Dimensiones	Satisfacción del paciente								Total	
	Fiabilidad		Respuesta		Garantía		Empatía		fi	%
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%		
Bajo	40	11.8%	16	4.7%	20	5.9%	31	9.1%	340	100%
Medio	216	63.5%	204	60%	175	51.5%	177	52.1%	340	100%
Alto	84	24.7%	120	35.3%	145	42.6%	132	38.8%	340	100%

Nota. Instrumento aplicado

En la tabla 3, se observa que, referente a las dimensiones de satisfacción del paciente: fiabilidad, respuesta, garantía y empatía, predomina la media satisfacción de los pacientes atendidos en el servicio de rayos x (63.5%, 60%, 51.5% y 52.1%, respectivamente).

Tabla 4.

Relación entre las dimensiones de acceso a los servicios y satisfacción.

		Dimensión Fiabilidad						Dimensión Respuesta						Dimensión Garantía						Dimensión Empatía					
		Bajo		Medio		Alto		Bajo		Medio		Alto		Bajo		Medio		Alto		Bajo		Medio		Alto	
		fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Dimensión Geográfica	Bajo	4	1.17%	8	2.35%	1	0.29%	2	0.58%	10	2.94%	1	0.29%	6	1.76%	6	1.76%	1	0.29%	3	0.88%	8	2.35%	2	0.58%
	Regular	25	7.35%	160	47.05%	53	15.58%	12	3.52%	154	45.29%	72	21.17%	13	3.82%	136	40%	89	26.17%	25	7.35%	136	40%	77	22.64%
	Alto	11	3.23%	48	14.11%	30	8.82%	2	0.58%	40	11.76%	47	13.82%	1	0.29%	33	9.70%	55	16.17%	3	0.88%	33	9.70%	53	15.58%
		<i>Chi² 11.164^a, gl= 4, valor de p=0,025</i>						<i>Chi² 21,468^a, gl= 4, valor de p=0,000</i>						<i>Chi² 57,398^a, gl= 4, valor de p=0,000</i>						<i>Chi² 26,001^a, gl= 4, valor de p=0,000</i>					
Dimensión Administración	Bajo	13	3.82%	38	11.17%	10	2.94%	7	2.05%	34	10%	20	5.88%	5	1.47%	31	9.11%	25	7.35%	6	1.76%	31	9.11%	24	7.05%
	Regular	24	7.05%	170	50%	66	19.41%	9	2.64%	160	47.05%	91	26.76%	14	4.11%	135	39.70%	111	32.64%	24	7.05%	137	40.29%	99	29.11%
	Alto	9	0.88%	8	2.35%	8	2.35%	0	0%	10	2.94%	9	2.64%	1	0.29%	9	2.64%	9	2.64%	1	0.29%	9	2.64%	9	2.64%
		<i>Chi² 12.017^a, gl= 4, valor de p=0,017</i>						<i>Chi² 9,049^a, gl= 4, valor p=0,060</i>						<i>Chi² 0.894^a, gl= 4, valor de p=0,925</i>						<i>Chi² 0,865^a, gl= 4, valor de p=0,930</i>					

		Dimensión Fiabilidad						Dimensión Respuesta						Dimensión Garantía						Dimensión Empatía					
		Bajo		Medio		Alto		Bajo		Medio		Alto		Bajo		Medio		Alto		Bajo		Medio		Alto	
		fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Dimensión Sociocultural	Bajo	4	1.17%	8	2.35%	5	1.47%	3	0.88%	7	2.05%	7	2.05%	1	0.29%	8	2.35%	8	2.35%	2	0.52%	6	1.76%	9	2.64%
	Regular	27	7.94%	160	47.05%	58	17.05%	10	2.94%	151	44.41%	84	24.70%	17	5%	123	36.17%	105	30.88%	25	7.35%	131	35.52%	89	26.17%
	Alto	9	2.64%	48	14.11%	21	6.17%	3	0.88%	46	13.52%	29	8.52%	2	0.58%	44	12.94%	32	9.41%	4	1.17%	40	11.76%	34	10%
		Chi² 3,428ª, gl= 4, valor de p=0,489						Chi² 7,818ª, gl= 4, valor de p=0,098						Chi² 2,563ª, gl= 4, valor de p=0,633						Chi² 4,552ª, gl= 4, valor p=0,336					
Dimensión Administración	Bajo	9	3.52%	56	16.47%	17	5%	5	1.47%	55	16.17%	25	7.35%	7	2.05%	44	12.94%	34	10%	6	1.76%	50	14.70%	29	8.52%
	Regular	27	7.94%	147	43.23%	62	18.23%	10	2.94%	135	39.70%	91	26.76%	13	3.82%	122	35.88%	101	29.70%	23	6.76%	121	35.58%	92	27.05%
	Alto	1	0.29%	13	3.82%	5	1.47%	1	0.29%	14	4.11%	4	1.17%	0	0%	9	2.64%	10	2.94%	2	0.58%	6	1.76%	11	3.23%
		Chi² 2,322ª, gl= 4, valor p=0,677						Chi² 4,225ª, gl= 4, valor de p=0,376						Chi² 2,625ª, gl= 4, valor de p=0,622						Chi² 5,111ª, gl= 4, valor de p=0,276					

En la tabla 4, se muestra que existe una correlación significativa entre las dimensiones, fiabilidad y geográfica (χ^2 11, 164a, valor de $p=0,025$), respuesta y geográfica (χ^2 21, 468a, valor de $p=0,000$), garantía y geográfica (χ^2 57, 398a, valor de $p=0,000$), empatía y geográfica (χ^2 26,001^a, valor de $p=0,000$), fiabilidad y administración (χ^2 12.017^a, valor de $p=0,017$), fiabilidad y geográfica (χ^2 32.169, valor de $p=0,025$).

Tabla 5.*Variables sociodemográficas según el acceso a servicios de salud.*

Variables sociodemográficas (n=340)	Acceso a los servicios de salud						X ²	p
	Bajo		Regular		Alto			
	fi	%	fi	%	fi	%		
Edad								
18-29	0	0%	84	35%	10	4.16%	4.174 ^a	0,841
30-39	3	1.25%	105	43.75%	10	4.16%		
40-49	2	0.83%	70	29.16%	9	3.75%		
50-59	1	0.41%	37	15.41%	2	0.83%		
60+	0	0%	6	2.5%	1	0.41%		
Sexo								
Masculino	2	0.83%	153	63.74%	18	7.50%	1.114 ^a ,	0,573
Femenino	4	1.66%	149	62.08%	14	5.83%		
Grado de instrucción								
Primaria	0	0%	3	1.25%	2	0.83%	13.924 ^a	0,031
Secundaria	5	2.08%	91	37.91%	10	4.16%		
Superior técnico	0	0%	89	37.08%	10	4.16%		
Sup. universitario	1	0.41%	119	49.58%	10	4.16%		
Tipo de trabajo								
Dependiente	0	0%	160	66.66%	15	6.25%	20.835 ^a	0,002
Independiente	1	0.41%	69	28.74%	11	4.585		
Ama de casa	5	2.08%	51	21.25%	5	2.08%		
Eventual	0	0%	22	9.16%	1	0.41%		
Tipo de seguro								
SIS	6	2.50%	195	81.25%	23	9.58%	4.458 ^a ,	0,348
Essalud	0	0%	99	41.25%	9	3.75%		
SaludPol	0	0%	8	3.33%	0	0%		
Ingreso económico								
Mayor al sueldo mínimo	2	0.83%	219	91.25%	25	10.425	5.104 ^a	0,078
Menor al sueldo mínimo	4	1.67%	83	34.58%	7	2.92%		
Tipo de radiografía								
Simple	6	2.5%	283	118.75%	29	12.08%	0.877 ^a ,	0,645
Con contraste	0	0	19	7.92%	3	1.25%		

Nota. Instrumento aplicado

En la tabla 5, se demuestra que el 43.75% de pacientes son de edades entre 30 a 39 años, el 63.74% son de sexo masculino, el 49.58% tienen grado de instrucción universitaria, el 66.66% tienen trabajo dependiente, el 81.25% de los pacientes tienen seguro integral de salud, el 91.25% tienen ingreso económico mayor al sueldo mínimo vital y el 118.75% de los pacientes se tomaron radiografía simple. Todos los anteriores demostraron un valor regular de acceso a los servicios de salud.

Asimismo, se demuestra que existe una correlación estadísticamente significativa con las variables de grado de instrucción (Chi^2 13.924^a, y $p=0,031$) y con el tipo de trabajo (Chi^2 20.835^a, y $p=0,002$), las demás variables no existen correlación significativa.

Tabla 6.*Variables sociodemográficas según la satisfacción del paciente.*

Variables sociodemográficas (n=340)	Satisfacción del paciente						X ²	p
	Bajo		Medio		Alto			
	fi	%	fi	%	fi	%		
Edad								
18-29	0	0%	84	35%	10	4.16%	4.174 ^a	0,841
30-39	3	1.25%	105	43.75%	10	4.16%		
40-49	2	0.83%	70	29.17%	9	3.75%		
50-59	1	0.42%	37	15.42%	2	0.83%		
60+	0	0%	6	2.5%	1	0.41%		
Sexo								
Masculino	2	0.83%	116	48.33%	55	22.92%	1.114 ^a ,	0,573
Femenino	6	2.5%	108	45%	53	22.08%		
Grado de instrucción								
Primaria	0	0%	1	0.42%	4	1.67%	13.924 ^a	0,031
Secundaria	3	1.25%	70	29.17%	33	13.75%		
Superior técnico	1	0.42%	69	28.75%	29	12.08%		
Sup. universitario	4	1.67%	84	35%	42	17.50%		
Tipo de trabajo								
Dependiente	4	1.17%	117	34.41%	54	15.88%	20.835 ^a	0,002
Independiente	1	0.29%	52	15.29%	28	8.23%		
Ama de casa	2	0.58%	40	11.76%	29	12.08%		
Eventual	1	0.29%	15	4.41%	42	14.50%		
Tipo de seguro								
SIS	4	1.17%	143	42.05%	77	22.64%	4.458 ^a ,	0,348
Essalud	3	0.88%	75	22.05%	30	8.82%		
SaludPol	1	0.29%	6	1.76%	1	0.29%		
Ingreso económico								
Mayor al sueldo mínimo	5	1.47%	161	47.35%	80	23.52%	5.104 ^a	0,078
Menor al sueldo mínimo	3	0.88%	63	18.52%	28	8.23%		
Tipo de radiografía								
Simple	6	1.76%	206	60.58%	106	31.17%	0.877 ^a ,	0,645
Con contraste	2	0.58%	18	5.29%	2	0.58%		

Nota. Instrumento aplicado

En la tabla 6, se demuestra que el 43.75% de pacientes son de edades entre 30 a 39 años, el 48.33% son de sexo masculino, el 29.17% tienen grado de instrucción secundaria, el 34.41% tiene trabajo dependiente, el 42.05% de los pacientes tienen seguro integral de salud, el 47.35% tienen ingreso económico mayor al sueldo mínimo vital y el 60.58% de los pacientes se tomaron radiografía simple. Todos los anteriores demostraron una media satisfacción.

Asimismo, se demuestra que existe una correlación estadísticamente significativa con las variables de grado de instrucción (Chi^2 13.924^a, y $p=0,031$) y con el tipo de radiografía (Chi^2 9.252^a y $p=0,010$), las demás variables no existen correlación significativa.

IV. DISCUSIÓN

En este estudio, se demostró una correlación estadísticamente relevante entre el acceso a los servicios sanitarios y el grado de satisfacción de los pacientes, con un valor de $p=0,000$, lo que señala una probabilidad extremadamente reducida de que este resultado sea resultado de la casualidad. Este hallazgo resalta la relevancia del acceso correcto y a tiempo a los servicios sanitarios como elemento crucial en la percepción y satisfacción del paciente. El fortalecimiento de esta conexión indica que incrementar la disponibilidad y la calidad del acceso podría tener un impacto positivo en la experiencia y la satisfacción global de los usuarios del sistema sanitario.

En áreas como Chachapoyas, donde existen barreras geográficas, económicas y administrativas, las visitas en su mayoría regulares pueden reflejar los esfuerzos del sistema para reducir estas barreras, aunque aún son insuficientes para garantizar un acceso óptimo. Los resultados de esta investigación señalan que la satisfacción del paciente se ve significativamente influenciada por el acceso y la calidad de los servicios de salud que se han conseguido. Estos hallazgos pueden examinarse a través de la teoría de Expectativa-Confirmación, la cual propone que la satisfacción se produce cuando las expectativas iniciales de los pacientes se alinean con la experiencia real del servicio. En este estudio, las expectativas en cuanto a la rapidez de respuesta y la empatía del personal fueron elementos que impactaron positivamente en la satisfacción percibida, ya que estos factores fueron considerados apropiados o incluso más allá de lo esperado (Oliver, 2017).

Los descubrimientos de Torres (2021), en el Hospital Regional de Amazonas, Perú, y de Ruiz (2023) en Ecuador, subrayan la importancia de elementos particulares en la percepción de calidad y satisfacción del paciente en los servicios sanitarios en Latinoamérica, lo cual concuerda con los hallazgos de esta disertación. El estudio de Torres mostró un elevado grado de satisfacción en la dimensión de respuesta, subrayando la relevancia de la rapidez y eficiencia en la percepción de la calidad del servicio. Esto concuerda con los resultados de este estudio, que indica la respuesta del sistema sanitario como un factor crucial en la satisfacción del paciente. Por otro lado, Ruiz detectó los retos de transporte y accesibilidad en Ecuador como elementos esenciales. Este punto concuerda con los hallazgos de esta tesis, en la que el acceso geográfico y la sencillez de transporte tienen una correlación significativa con la percepción de confiabilidad en los servicios sanitarios. Estas investigaciones enfatizan que tanto la respuesta efectiva como

la accesibilidad son factores cruciales en la satisfacción del paciente en entornos sanitarios de la región, consolidando la noción de que potenciar estos elementos podría influir positivamente en la percepción de calidad del sistema sanitario en naciones de América Latina.

Además, los resultados encontrados por Bustos y Baldeón (2020), junto con los de Orbea (2023), proporcionan una visión relevante acerca de cómo distintos elementos del acceso a los servicios sanitarios afectan la satisfacción de los pacientes, y proporcionan un contexto para los resultados de este estudio. Aunque Bustos y Baldeón reconocieron que el acceso económico y administrativo influía menos en la satisfacción general en su entorno, subrayaron que el acceso económico todavía representaba un impedimento significativo para los pacientes de ingresos bajos. Esto indica que las barreras económicas son significativas y pueden fluctuar en su peso dependiendo de las particularidades socioeconómicas de la población y del sistema de salud en análisis. Para este estudio, también se identificó el acceso a los servicios sanitarios como un factor clave.

Por otro lado, la dimensión de respuesta es particularmente valorada en diversos estudios, como la investigación de Torres (2021) y los hallazgos de su disertación subrayan que una reacción eficaz es fundamental para la satisfacción del paciente. Sin embargo, en Ecuador, Orbea (2023) halló que la capacidad de respuesta representó la dimensión con mayor insatisfacción, con un 42% de insatisfacción, lo que podría sugerir variaciones en los estándares de operación o discrepancias culturales en las expectativas de los pacientes respecto a la calidad del cuidado; estos contrastes enfatizan la importancia de considerar tanto el contexto socioeconómico como las percepciones culturales al evaluar la satisfacción del paciente, y sugieren que los elementos de accesibilidad y respuesta deberían ajustarse a las exigencias y necesidades del paciente.

Se detectó una relación significativa entre el tipo de radiografía (sencilla o con contraste) y la satisfacción del paciente. Los pacientes que recibieron radiografías con contraste mostraron niveles de satisfacción más bajos, lo que podría ser resultado de la complejidad y el tiempo requeridos para el procedimiento. Gonzales (2022) igualmente reportó que tanto la oferta de servicios de radiología como el tipo de procedimiento afectaban la satisfacción del paciente, enfatizando la importancia de procedimientos menos complejos en la percepción de calidad. A diferencia de estudios previos que no investigaron a fondo

los tipos específicos de procedimientos, este estudio brinda valor al diferenciar entre radiografías básicas y contrastadas, demostrando cómo el tipo específico de procedimiento puede afectar la experiencia y la satisfacción del paciente.

Elementos sociodemográficos como el género, la edad, sexo, la condición civil y el tipo de seguro o de trabajo, no demostraron vínculos ni relación significativa con las dos variables de estudio, lo que sugiere una satisfacción uniforme sin importar estas características; no obstante, en investigaciones como la realizada por Gebru et al. (2019) en Etiopía, tanto el género como la edad tuvieron un impacto significativo en la satisfacción, con las mujeres reportando una mayor satisfacción que los hombres. Esto puede indicar que el entorno cultural y social puede afectar la percepción de los pacientes.

Aunque las dimensiones socioculturales y económicas no mostraron correlaciones estadísticamente significativas con la dimensión satisfacción, no se debe subestimar su importancia. La percepción de barreras económicas o culturales puede estar influenciada por factores externos al hospital, como el nivel educativo o la cultura local, lo que sugiere la necesidad de realizar más investigaciones para evaluar estos factores con mayor profundidad.

Los hallazgos presentados en la disertación muestran tanto coincidencias como discrepancias con los precedentes. Las coincidencias subrayan la relevancia de elementos como la eficacia del servicio y la disponibilidad geográfica, lo que fortalece la noción de que estos factores influyen en la satisfacción en diversos contextos. Por otro lado, las discrepancias subrayan la importancia de ajustar las estrategias de atención a las particularidades específicas de cada grupo poblacional y de cada entorno de atención sanitaria.

En este contexto los resultados de la tesis indican que el hospital debe enfocarse en relación a la teoría de expectativa-confirmación, se puede incrementar la satisfacción del paciente al manejar de forma eficiente las expectativas, como comunicar a los pacientes acerca de los plazos de espera previstos y establecer un diálogo claro acerca de los servicios existentes podría disminuir la diferencia entre las expectativas y la vivencia, adicionalmente, la implementación de mejoras en el aspecto de accesibilidad podría

ayudar a incrementar la percepción de calidad y satisfacer de manera más efectiva las expectativas de los usuarios respecto al acceso a servicios sanitarios.

La confiabilidad, que se relaciona con la capacidad del sistema para satisfacer las expectativas del paciente, y la empatía, que se refiere a la calidad de la interacción entre el ser humano y el proveedor, son dimensiones clave que requieren especial atención para mejorar la experiencia del paciente. Los resultados obtenidos son consistentes con estudios previos que enfatizan la importancia de la accesibilidad en la satisfacción del paciente, pero aportan una nueva perspectiva al analizar cómo cada dimensión de la accesibilidad afecta a diferentes aspectos de la satisfacción en un servicio especializado, como la radiología.

Es crucial considerar que esta investigación se centró en un único hospital, lo que podría limitar la extensión de los descubrimientos. Sería beneficioso replicar este análisis en otros centros de salud en diferentes contextos culturales para confirmar si estos descubrimientos son coherentes. Además, investigaciones futuras podrían ahondar más en los factores que influyen particularmente en la satisfacción en procedimientos médicos complejos y cómo estos pueden ser optimizados.

Para concluir, esta investigación permite corroborar y coincidir con ciertos elementos establecidos en la literatura acerca del acceso y satisfacción en los servicios sanitarios, mientras que otros hallazgos nos generan nuevos mercados de investigación y reflexión acerca de cómo potenciar la calidad de satisfacción en el ámbito de la radiología. La relación entre la calidad del servicio, el método de procedimiento y el acceso en términos geográficos y financieros se destaca como un elemento crucial para la elaboración de políticas de salud en el Hospital Virgen de Fátima de Amazonas y potencialmente en otros centros sanitarios en Perú.

V. CONCLUSIONES

- ✓ Se ha evidenciado una relación estadísticamente relevante entre la disponibilidad de servicios sanitarios y la satisfacción de los pacientes en el departamento de radiología del Hospital Regional Virgen de Fátima de Amazonas. Este hallazgo enfatiza el valor de optimizar las condiciones de acceso a los servicios sanitarios como una táctica esencial para aumentar la satisfacción del paciente.
- ✓ Respecto a las dimensiones de acceso a los servicios sanitarios: geográfica, administrativa, sociocultural y económica, la mayor parte de los pacientes indican un acceso constante, pese a que un gran número de pacientes tiene acceso a los servicios, hay barreras significativas en cada una de estas dimensiones que podrían estar restringiendo una atención más eficaz y gratificante.
- ✓ Respecto a los aspectos de satisfacción del paciente: fiabilidad, respuesta, garantía y empatía, predomina una satisfacción media entre los pacientes que reciben atención en el servicio de radiografías, en promedio estas dimensiones indican la importancia de concentrar esfuerzos en potenciar la confiabilidad del diagnóstico, mejorar los tiempos de respuesta, asegurar un mayor nivel de seguridad y confianza en los procedimientos, y optimizar la satisfacción media.
- ✓ Se demostró que existe una correlación significativa entre las dimensiones geográfica con fiabilidad, sociocultural con respuesta, económica con garantía, y administrativo organizacional con empatía, esto indica que, a pesar de que las conexiones entre estas dimensiones no son muy intensas, sí hay un vínculo significativo que necesita ser tratado para potenciar tanto el acceso como la satisfacción del paciente.

VI. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda a la Dirección Regional de Salud realizar una actualización y mantenimiento continuo de las instalaciones de salud, asegurando que los equipos estén en condiciones óptimas y que los espacios sean adecuados para brindar una atención cómoda y digna. Además, es fundamental implementar programas de capacitación periódica para el personal de salud, enfocándose en la atención al paciente, la empatía y la comunicación efectiva, con el fin de mejorar la experiencia del usuario. Esta capacitación debe promover una cultura de respeto, trato humano y sensibilidad cultural, factores clave para incrementar la satisfacción del paciente.
- ✓ Al Hospital, se recomienda implementar una estrategia de optimización del acceso, especialmente para pacientes en áreas rurales o con recursos limitados, mediante la mejora de la infraestructura, y la accesibilidad económica, asimismo, se sugiere simplificar los procedimientos administrativos, con el propósito de agilizar la atención, reducir los tiempos de espera y aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios.
- ✓ Al servicio de radiología, sería indispensable que reciban formación constante en competencias de comunicación, empatía y atención al paciente, con el fin de fomentar una cultura de atención personalizada, donde los pacientes reciban explicaciones exactas sobre los procedimientos y se les brinde apoyo emocional durante su experiencia en el servicio radiológico.
- ✓ Se recomienda a los pacientes expresar de manera clara sus preocupaciones y síntomas durante las consultas, lo que permitirá una evaluación más precisa. Además, se sugiere compartir su experiencia y ofrecer sugerencias sobre la atención recibida, ya sea a través de encuestas o directamente con el personal, contribuyendo así a la mejora de la calidad de los servicios. Finalmente, es esencial que los pacientes se informen sobre sus derechos, asegurándose de recibir una atención digna, oportuna y de calidad.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andersen, R. M. (2019). Revisiting the behavioral model and access to medical care: Does it matter? *Journal of Health and Social Behavior*, 36(1), 1-10.
- Bustos, & Baldeón. (2020). Derechos al acceso de los servicios de salud y satisfacción del usuario externo, Hospital I EsSalud Tarma 2020. *Universidad Peruana Los Andes*. <http://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/1958>
- Castillejos, & Moreno. (2022). Relación entre la prestación de servicio de salud y la satisfacción del paciente del Hospital Amazónico de Yarinacocha. *Universidad Nacional de Ucayali*. <http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/5867>
- Díaz, & Esteban. (2020). Calidad percibida por el paciente en el servicio de radiología: Estudio comparativo entre hospitales. *Tiempos de enfermería y salud = Nursing and health times*, 8, 28-33. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7610290>
- Febres, & Mercado. (2020). Satisfacción del usuario y calidad de atención del servicio de medicina interna del Hospital Daniel Alcides Carrión. Huancayo—Perú. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 20(3), 397-403. <https://doi.org/10.25176/rfmh.v20i3.3123>
- Gebbru, A. A., Mosadeghrad, A. M., Sari, A. A., Tafesse, T. B., & Kahsay, W. G. (2019). Client satisfaction on Emergency department services and quality of emergency medical care in Ethiopia: A systematic review. *Human Antibodies*, 27(S1), 23-31. <https://doi.org/10.3233/HAB-190367>
- Monitor del Servicio de Salud Global (2020). Obtenido de <https://www.ipsos.com/es-co/monitor-del-servicio-de-salud-global-2020>

- Gonzales. (2022). Oferta de servicios y satisfacción del usuario externo del servicio de radiología del Hospital Santa Rosa, Lima—Perú 2021. *Repositorio institucional-WIENER*. <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/6568>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2014). Selección de la muestra. En *Metodología de la Investigación* (6ª ed., pp. 170-191). México: McGraw-Hill.
- Hernández, & Mendoza. (2019). *Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta | RUDICS*. <https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612>
- Holguín, N. C. J., Vélez, C. E., & Jiménez, W. G. (2020). Índice de satisfacción multidimensional. Una propuesta para la evaluación de la calidad de los servicios de salud desde la perspectiva de los usuarios. *Acta Odontológica Colombiana*, 3(1), Article 1.
- Minsa. (2022). Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector Salud. Obtenido de <https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2022/diagnosticobrechas-infraestructura-sector-salud-2022.pdf>
- Okafor, C. H., Ugwu, A. C., & Okon, I. E. (2019). Effects of Patient Safety Culture on Patient Satisfaction With Radiological Services in Nigerian Radiodiagnostic Practice. *Journal of Patient Experience*, 5(4), 267-271. <https://doi.org/10.1177/2374373518755500>
- OMS. (2023). Estudio sobre la salud en el mundo. OMS.
- Orbea. (2023). Calidad de atención y nivel de satisfacción de los usuarios del área de radiología en un consorcio médico de la ciudad de Quito Ecuador. *Repositorio Académico USMP*. <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/12947>

- OPS. (2015). *Planificación y Gestión en Recursos Humanos en Salud en los Países Andinos*. Obtenido de <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3592.pdf>
- Perez. (2021). Acceso al servicio de salud y satisfacción multidimensional en paciente externo Hospital Andahuaylas, 2020. *Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/58937>
- Ruiz. (2023). *Barreras de acceso a los servicios de salud en la población adulta mayor que acude a la unidad San Buenaventura – Latacunga durante el periodo febrero—Junio 2023* [Thesis, QUITO/UIDE/2023]. <https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6404>
- Tanta. (2022). *Calidad de atención y satisfacción del usuario del servicio de radiología de un hospital de Lima en el año 2022*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/97027>
- Tercero. (2019). *Satisfacción de los usuarios del área de rayos X. servicio de imagenología, Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, Managua Nicaragua, Febrero—Marzo 2019*. 61-61. <http://cies.edu.ni/cedoc/digitaliza/t1077/t1077.pdf>
- Torres. (2021). Nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en el servicio de emergencia del hospital regional Virgen de Fátima, Chachapoyas, marzo, 2019. *Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM*. <https://repositorio.untrm.edu.pe/handle/20.500.14077/2392>
- Videnza Instituto. (2022). Historia Clínica Electrónica. Obtenido de Propuestas del Bicentenario: <https://propuestasdelbicentenario.pe/observatorio/#/salud/325>

ANEXOS

ANEXO 1

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Definición conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Categoría		Escala
						Dimensión	Variable	
Acceso a los servicios de salud	Capacidad de utilizar los servicios de salud cuando y donde sea necesario, además de “el tiempo que emplea el personal de los servicios de salud para lograr el mejor resultado en salud (Andersen, 2016). Se medirá a través una encuesta elaborado por (Perez, 2021)	El acceso a servicios de salud se definirá operacionalmente como la capacidad de una persona para obtener atención médica cuando la necesite, permitiendo una evaluación precisa de la accesibilidad y de atención médica, Se medirá a través una encuesta elaborado por (Perez, 2021)	Acceso geográfico	Distancia Transporte	1 – 4	Alto: 15-20 Medio: 10-14 Bajo: 4-9	Alto acceso al servicio 59-80 Medio acceso al servicio 38-58 Bajo acceso al servicio 16-37	Escala: ordinal Nivel: politómica 0= Nunca 2= Casi nunca 3= Algunas veces 4= Casi siempre 5= Siempre
			Acceso administrativo organizacional	Atención Tiempo	5 – 8	Alto: 15-20 Medio: 10-14 Bajo: 4-9		
			Acceso sociocultural	Percepción del trato	9 – 12	Alto: 15-20 Medio: 10-14 Bajo: 4-9		
			Acceso económico	Grado de traslado Deja de percibir	13 – 16	Alto: 15-20 Medio: 10-14 Bajo: 4-9		

Variable	Definición conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Categoría		Escala
						Dimensión	Variable	
Satisfacción del paciente	Posibilidad o nivel de lograr llenar o cubrir un deseo o necesidad. Evaluación positiva que éste hace sobre las diferentes dimensiones de la atención médica recibida (Holguín et al., 2013)	Se utilizará un instrumento de 15 preguntas elaboradas por (Gonzales, 2022), distribuidas en cuatro dimensiones las respuestas serán ponderadas utilizando la escala de Likert con cinco opciones para responder desde totalmente insatisfecho hasta totalmente satisfecho.	Fiabilidad	Conformidad Horario de atención	1 – 3	Alto: 11-15 Medio: 7-10 Bajo: 3-6	Nivel bajo: de 15 a 34 puntos. Nivel medio: de 35 a 54 puntos. Nivel alto: de 55 a 75 puntos.	Escala: ordinal Nivel: politómica Totalmente insatisfecho = 1 Parcialmente insatisfecho = 2 Parcialmente satisfecho = 3 Medianamente satisfecho = 4 Totalmente satisfecho = 5
			Capacidad de respuesta	Espera para cita Espera para atención	4 – 7	Alto: 15-20 Medio: 10-14 Bajo: 4-9		
			Garantía	Percepción Privacidad	8 - 11	Alto: 15-20 Medio: 10-14 Bajo: 4-9		
			Empatía	Calidad profesional Interpersonal Atención brindada	12 - 15	Alto: 15-20 Medio: 10-14 Bajo: 4-9		



ANEXO 1

CUESTIONARIO DE ACCESO DEL SERVICIO DE SALUD

(Perez, 2021)

Código:

12

Presentación:

Querido paciente, nos comunicamos con usted para pedirle unos momentos de su tiempo con el propósito de llevar a cabo la encuesta que se presenta a continuación con el objetivo de determinar la relación entre accesos a los servicios de salud y satisfacción del paciente. Esta encuesta se considera estrictamente confidencial.

Indicaciones:

Por favor, lea detenidamente todas las preguntas y seleccione la opción que considere más apropiada marcándola con una (x).

I. Datos generales:

Edad:	...39..... años			
Sexo:	☒ M		☒ F	
Nivel educativo	☒ Primaria	☐ Secundaria	☐ Superior Técnico	☐ universitario
Estado civil	☐ Soltero	☐ Casado	☒ Conviviente	☐ Viudo
Tipo de trabajo	☐ Empleado público	☐ Independiente	☐ Dependiente	☒ Hogar
Tipo de seguro	☒ SIS	☐ ESSALUD		☐ SALUDPOL
Ingreso económico	Mayor al sueldo mínimo vital (S/ 1025.00)		Menor al sueldo mínimo vital (S/ 1025.00)	
Tipo de radiografía realizada	☒ Simple		☐ Especial o con contraste	

II. Ítems

Nº	ITEMS	Nunca	Casi Nunca	Aveces	Casi Siempre	Siempre
1	¿Considera usted adecuada la distancia existente entre su domicilio y el Hospital?	1	2	3	4	5
2	¿Le es fácil llegar desde su domicilio al Hospital Virgen de Fátima?	1	2	3	4	5

3	¿Le es fácil encontrar transporte público para llegar al Hospital cuando va a su cita?	1	2	3	4	5
4	Cuando realiza los trámites para ser atendido en el Hospital ¿le es fácil movilizarse desde allí a otros lugares?	1	2	3	4	5
5	¿Considera usted que los trámites administrativos para ser atendido fueron sencillos?	1	2	3	4	5
6	¿Considera usted que la atención que recibe en el Hospital es rápida?	1	2	3	4	5
7	¿El tiempo de espera para obtener esta cita le pareció adecuado?	1	2	3	4	5
8	¿El tiempo que esperó entre la fecha que le dieron la cita hasta el día de la atención fue aceptable?	1	2	3	4	5
9	¿El trato del personal del Hospital es amable y respetuoso?	1	2	3	4	5
10	¿Considera usted que el profesional del Hospital tiene un trato ético y profesional?	1	2	3	4	5
11	¿Le transmite confianza y seguridad el personal del Hospital?	1	2	3	4	5
12	¿Considera usted que el profesional que le atiende del Hospital tiene credibilidad?	1	2	3	4	5
13	¿Considera usted que el gasto que le ocasiona el acudir a la atención al consultorio externo del Hospital es aceptable?	1	2	3	4	5
14	¿Considera usted adecuado el costo de los exámenes del Hospital?	1	2	3	4	5
15	¿Puede costear los gastos para acudir a su cita y tratamiento del Hospital?	1	2	3	4	5
16	¿Usted y/o acompañante no tiene que dejar de trabajar para asistir a la cita del Hospital?	1	2	3	4	5

ANEXO 2

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

(Gonzales, 2022)

De las siguientes preguntas, seleccione la respuesta más adecuada siendo:

1. Totalmente insatisfecho.
2. Parcialmente insatisfecho.
3. Parcialmente satisfecho.
4. Medianamente satisfecho.
5. Totalmente satisfecho.

Nº	Enunciado	1	2	3	4	5
Fiabilidad						
1	¿El personal administrativo le brindó la orientación adecuada para conseguir una cita de rayos x, ecografía o tomografía?					X
2	¿El día de su cita, lo atendieron en la hora que usted estaba citado?			X		
3	¿Considera usted que respetaron el orden de su programación?		X			
Respuesta						
4	¿Consiguió usted una cita para un examen para rayos x, ecografía o tomografía, pronta a su necesidad de atención?				X	
5	¿La atención para conseguir una cita para rayos x, ecografía o tomografía fue rápida?				X	
6	¿La atención en el servicio inicial donde le indicaron el examen fue rápida?				X	
7	¿Al momento de brindarle la cita para rayos x, ecografía o tomografía, resolvieron todas sus dudas?				X	
Garantía						
8	¿Considera usted que el servicio recibido en rayos x, ecografía o tomografía fue óptimo?				X	
9	¿Los exámenes radiológicos de rayos x, ecografía o tomografía que le indicaron, correspondía al órgano o a la enfermedad que lo afecta?				X	
10	¿Considera usted que durante su atención respetaron su privacidad?				X	
11	¿Considera usted los profesionales que lo atendieron fueron minuciosos antes, durante y después de su atención?				X	
Empatía						
12	¿Considera usted que lo atendieron con amabilidad?					X
13	¿Considera usted que las personas que lo atendieron mostraron interés por solucionar sus dudas durante su atención?					X
14	¿Considera usted que fue satisfactoria las indicaciones que le brindaron respecto a lo que se requiere para su examen?					X
15	¿Considera usted que fue satisfactoria las explicaciones que le brindaron respecto a los resultados de su examen?					X

Muchas gracias por su colaboración

ANEXO 3

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se le está extendiendo una invitación para formar parte de este estudio de investigación que tiene como objetivo evaluar la conexión entre la disponibilidad de servicios ofrecidos por los usuarios en el área de radiología del Hospital Regional Virgen de Fátima de Amazonas. Antes de tomar su decisión sobre si desea participar o no, es importante que se familiarice y comprenda todos los elementos que se detallan a continuación.

Título de proyecyo: “Acceso a servicios de salud y satisfacción del paciente, servicio radiología, Hospital Regional, Amazona 2024”

Nombre de la investigadora principal: Zapata Baca Greisy Gledys.

Propósito del estudio: Determinar la relación entre acceso a servicios de salud y satisfacción del paciente, en el servicio de radiología del Hospital Regional Virgen de Fátima de Amazona 2024.

Beneficio por participar: No se ofrece ningún tipo de incentivo, ya sea de carácter económico u otro.

Riesgo del procedimiento: No se realizará ningún procedimiento.

Costo por participar: No tiene costo.

Confidencialidad: Los datos obtenidos tendrán absoluta reserva.

Renuncia: Ud. Tiene la libertad de retirarse del estudio en el momento que crea conveniente.

Contacto con el investigador: grero6714@gmail.com

Se le proporcionarán dos cuestionarios que requerirán aproximadamente 15 minutos de su tiempo, y si decide participar en este estudio, recibirá una copia de cada uno de ellos.

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Afirmo que he leído y entendido completamente. Tuve la oportunidad de plantear preguntas, las cuales fueron respondidas adecuadamente. No he sentido presiones ni influencias indebidas para participar o mantener mi participación en el estudio. Por último, acepto de manera voluntaria ser parte de la investigación.

.....de.....2024

Nombres y apellidos del participante		Firma o huella digital
N° de DNI:		
N° de teléfono o correo electrónico:		
Nombre y apellido del encuestador		Firma

ANEXO 4
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
(Perez, 2021)

JUEZ EVALUADOR	DNI	ESPECIALIDAD	OPCIÓN A APLICABILIDAD
Huaman Mendoza Wilber	40813602	Gestión en servicios de salud	Aplicable
Medrano Arias Mariela	3103575	Gestión en servicios de salud	Aplicable
Liliana Quispe Quispe	40269536	Gestión en servicios de salud	Aplicable

ANEXO 5
CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

(Perez, 2021)

		N	%
Casos	Válido	10	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	10	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,877	34

ANEXO 6

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

(Gonzales, 2022)

JUEZ EVALUADOR	DNI	ESPECIALIDAD	OPCIÓN A APLICABILIDAD	COMENTARIO
Dianet Pacheco Medina	25528765	Docencia universitaria	Aplicable	Si hay suficiencia
Jacobo Saldaña Juarez	06066929	Docencia universitaria	Aplicable	Si hay suficiencia
Edwin Rubén Acevedo Toralva	10154893	Docencia universitaria y gestión educativa	Aplicable	Si hay suficiencia
Mucha Bonifacio Hever Crisologo	20025978	Docencia universitaria y gestión educativa	Aplicable	Si hay suficiencia
Jannina Avalos Vigo	16805646	Tecnología en medicina nuclear molecular	Aplicable	Si hay suficiencia

ANEXO 7

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

(Gonzales, 2022)

Estadísticas de total de elemento				
	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
V19	37,40	173,792	,985	,998
V20	37,42	172,743	,984	,998
V21	37,39	173,020	,978	,998
V22	37,39	172,629	,987	,998
V23	37,35	172,904	,983	,998
V24	37,38	172,072	,979	,998
V25	37,35	173,033	,979	,998
V26	37,35	173,033	,979	,998
V27	37,34	172,841	,989	,998
V28	37,38	172,567	,992	,998
V29	37,41	171,605	,987	,998
V30	37,38	172,567	,992	,998
V31	37,35	173,626	,980	,998
V32	37,39	172,879	,976	,998
V33	37,38	172,567	,992	,998

Fuente: Elaboración propia.

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,998	15

Fuente: Elaboración propia.

Análisis e interpretación:

Se esperaba obtener valores de alfa de Cronbach > 0,8 para señalar que el instrumento es confiable.

Se obtuvo un valor = 0,998 lo que indica que el instrumento es altamente confiable.

ANEXO 8

CARTA DE SOLICITUD DE APROBACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

Chachapoyas, 26 de marzo del 2024.

CARTA N° 001-2024-UNTRM-AMAZONAS-EPG/GGZB

Sr.

Dr. Elías Torres Armas

Presidente del Comité de Ética en Investigación
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Presente.-

ASUNTO : SOLICITO REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE PARTE DE LA ESCUELA DE POS GRADO - UNTRM

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo solicitar la revisión y aprobación del proyecto de investigación titulado: "Acceso a servicios de salud y satisfacción de paciente servicio radiología Hospital Regional Amazonas, 2024", por el Comité de Ética en Investigación de la UNTRM. Adjunto proyecto de investigación.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Bach. GREISY GLEDYS ZAPATA BACA
Investigadora principal

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
FACU SALUD

MS. SONIA CELEDONIA HUYNHUA GUTIÉRREZ
Co-Investigador

C.c.
☐ Archivo.

CHACHAPOYAS – AMAZONAS – PERÚ

ANEXO 9

CONSTANCIA DE APROBACION POR COMITÉ DE ÉTICA



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

*Comité Institucional de Ética de la
Investigación (CIEI)*

CONSTANCIA

CIEI-N° 0053.

El que suscribe, presidente del comité institucional de ética en investigación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, deja constancia que el proyecto de investigación titulado:

“Acceso a los servicios de salud y satisfacción del paciente, servicio Radiología Hospital Regional Amazonas, 2024”

Ha sido evaluado por el comité, habiéndose encontrado que el proyecto está elaborado de acuerdo a los estándares propuestos para cumplir con los lineamientos éticos en la investigación y que se ejecutará bajo el patrocinio de (la/el): **Escuela Profesional de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas**; bajo la responsabilidad de **Greisy Gledys Zapata Baca**, como Investigador principal.

Chachapoyas, 24 de abril de 2024.

C/c
ciei



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
Alberto Torres Armas
DR. ALBERTO TORRES ARMAS
PRESIDENTE

ANEXO 10

CARTA DE SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE PROYECTO



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

EPG
ESCUELA DE POSGRADO

CARGO

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la
Commemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Chachapoyas, 22 de abril de 2024.

CARTA N° 002-2024-UNTRM/EPG/D

Señor:

DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA - CHACHAPOYAS

Por intermedio del presente me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo y a la vez manifestarle que a la señorita **GREISY GLEDYS ZAPATA BACA**, estudiante de la Maestría en Gerencia y Gestión en los Servicios de Salud de la UNTRM, se le aprobó su proyecto de tesis titulado **"Acceso a servicios de salud y satisfacción del paciente servicio radiología Hospital Regional Amazonas, 2024"**, el mismo que se encuentra para su pronta ejecución. Por lo cual; recorro a su Despacho para solicitar que se le brinde las facilidades necesarias a la antes citada maestrante, a fin de que pueda realizar la ejecución de su proyecto de tesis en el Hospital Regional Virgen de Fátima en el área de Radiología.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con nuestros(as) estudiantes, quedo de usted, no sin antes expresarle las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
CASTRO ALAYO EFRAIN
MANUELITO FIR 18204818 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 22/04/2024 16:36:0500

Expediente N° 2024-0049178

Remitente:
CIUDADANO - ZAPATA BACA GREISY GLEDYS - DNE
Destinatario: N° de Clave:
DE 38 3718
Recibido: 22/05/2024 - 15:11 N° Anexos: copia:
Referencia: Registrador:
ESCALANTE CHAVEZ AIDE

Observación:

Consultas: <https://www.gub.pe/regionalamazonas>
Teléfonos: (51) 044 - 477 855

Nota: La recepción MD da conformidad al contenido.

Escuela de Posgrado cel. 929347200, Chachapoyas-Perú
epg@untrm.edu.pe / www.untrm.edu.pe

ANEXO 11

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE TESIS



GOBIERNO REGIONAL } HOSPITAL REGIONAL
AMAZONAS "VIRGEN DE FÁTIMA"
CHACHAPOYAS



ESTABLECIMIENTO DE SALUD AMIGO DE LA MADRE, LA NIÑA Y EL NIÑO

EL COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE FÁTIMA" DE CHACHAPOYAS

CERTIFICA:

Que, el Proyecto de Investigación denominado "ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SERVICIO RADIOLOGIA HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE FATIMA" - CHACHAPOYAS 2024," presentado por la estudiante de la Maestría en Gerencia en los Servicios de Salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas Srta. **GREISY GLEDYS ZAPATA BACA** con **PROVEIDO N° 002972-2024-G.R.AMAZONAS/DE** a la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación fué **Aprobado** en la sesión extraordinaria del día 22 de mayo de 2024, esta aprobación se otorga por su Validez Científica, respeto a las normas legales vigentes, reglamento de Investigación Institucional y la satisfacción de los requisitos exigidos por la Ética en investigación.

El **Presente Certificado** tendrá una vigencia de 01 año a partir de emisión de esta constancia y obliga al investigador a ser responsable, notificar la fecha de inicio de Ejecución del Proyecto, los avances trimestrales, así como el Informe Final en cumplimiento del Reglamento de Investigación.

Dado en la Ciudad de Chachapoyas, con fecha 22 de mayo de 2024

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE FÁTIMA" - CHACHAPOYAS
Dra. VIANEY ALAGRITOS-BIAZ ILIQUIN
CDP: 21795 - REG: 102
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ÉTICA